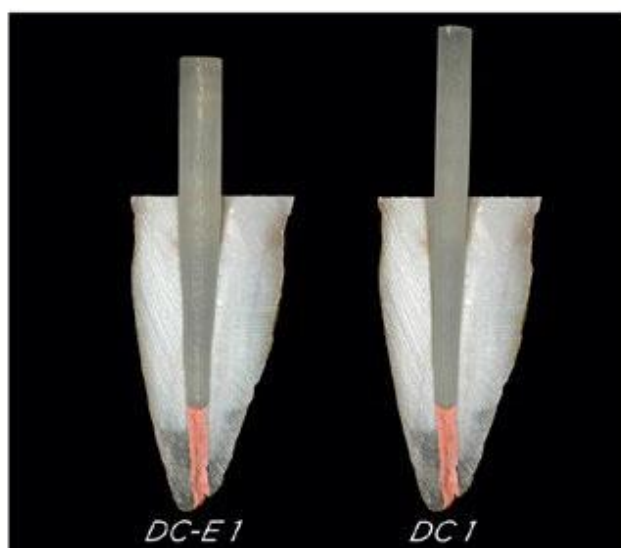


PROTOCOLO DE POSTES RADICULARES DE FIBRA DE VIDRIO

Clínica Universitaria de Odontología

Un poste radicular de composite reforzado con fibra de vidrio es un elemento prefabricado intrarradicular compuesto por fibras de vidrio embebidas en una matriz de resina polimérica, diseñado para reforzar y anclar la reconstrucción coronal de dientes previamente endodonciados con pérdida significativa de estructura dental. Su módulo de elasticidad se aproxima al de la dentina lo que favorece una distribución uniforme de tensiones y reduce la incidencia de fracturas radiculares irreparables. A su vez, su translucidez óptica elimina sombras metálicas bajo restauraciones cerámicas o composites, mejorando sustancialmente la estética final respecto a postes metálicos.



PRETRATAMIENTO DEL CONDUCTO RADICULAR

1. Verificar que el tratamiento de conductos esté correctamente sellado y sin filtraciones.
2. Colocar un aislamiento con dique de goma para mantener el campo operatorio seco.
3. Elegir el diámetro del poste según la imagen radiográfica y las dimensiones del conducto.
4. Calcular la longitud adecuada: conservar al menos 4 mm de obturación apical, alojar dos tercios del poste en el conducto y un tercio en la parte coronal del muñón.
5. Retirar la gutapercha con fresas Gates-Glidden, Peeso-Reamer o un instrumento caliente hasta alcanzar la profundidad planificada.
6. Realizar el fresado a baja velocidad (1.000–2.000 rpm) y contra-ángulo, respetando siempre la codificación de color del sistema utilizado y evitando sobrepasar el ápice o perforaciones laterales.
7. Durante el fresado, irrigar con frecuencia y limpiar las fresas para eliminar restos de dentina.
8. Realizar radiografías de comprobación con las fresas de eliminación de la gutapercha
9. Limpiar el poste con alcohol isopropílico antes de su inserción.
10. Comprobar que el poste encaje ajustadamente sin quedar flojo ni generar efecto cuña.
11. Reducir el poste a la longitud necesaria extraoralmente, utilizando puntas diamantadas y evitando herramientas de corte manual que puedan fracturar las fibras.
12. Nuevamente, limpiar y secar el poste con alcohol.
13. Aplicar silano sobre la superficie del poste, dejar actuar un minuto y secar con la jeringa de aire.
14. Irrigar el interior del conducto con hipoclorito de sodio al 2,5–5 %; evitar peróxidos y agentes quelantes como EDTA que comprometan la adhesión.
15. Aclarar con agua y secar con puntas de papel estériles antes de proceder al cementado.

FIJACIÓN ADHESIVA

1. Aplicación del adhesivo autograble de curado dual (Futurabond DC - VOCO) en el conducto y en las superficies expuestas del diente sin polimerizar, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Nota: si la corona clínica presentara esmalte remanente que será utilizado como parte del muñón este será grabado con ác. Ortofosfórico al 37%.

2. Aplicar el cemento de composite de curado dual en el conducto empleando dos técnicas alternativas:

- a. Con cartucho y cánula de mezcla tipo 19 (Rebilda® post system): acoplar la cánula de mezcla, introducir el cemento de composite de curado dual en el conducto y, si es necesario, doblar manualmente la aguja de aplicación para facilitar el acceso. En ausencia de la cánula de mezcla tipo 19, humedecer previamente el poste con el cemento en lugar de verterlo directamente en el conducto. No emplear aplicadores tipo léntulo. Insertar el poste con movimientos de rotación suave, generando un ligero extravasado de cemento y retirar los excesos de cemento antes de continuar si el muñón se reconstruirá con otro material.
- b. Con jeringa QuickMix y punta intrabucal fina (Rebilda® post system): inyectar el cemento de composite de curado dual directamente desde la porción apical del conducto, manteniendo la punta sumergida en el cemento durante la inyección. No emplear léntulos. Alternativamente, impregnar el poste con cemento antes de su colocación, realizando la inserción con rotación ligera hasta crear un pequeño exceso cementante. Eliminar cualquier exceso si el muñón se reconstruirá con otro material.

3. Fotopolimerizar durante 40 sg en la superficie oclusal una vez colocado el poste y aplicado el adhesivo autograble de curado dual en las superficies expuestas. Evitar cualquier material que contenga eugenol (incluidos algunos selladores de conducto), pues inhibe la polimerización de los composites adhesivos.

RECONSTRUCCIÓN DEL MUÑÓN

1. Ejecutar la restauración coronal siguiendo fielmente el protocolo del material seleccionado de acuerdo con sus instrucciones de uso.

CHECKLIST OPERATIVO

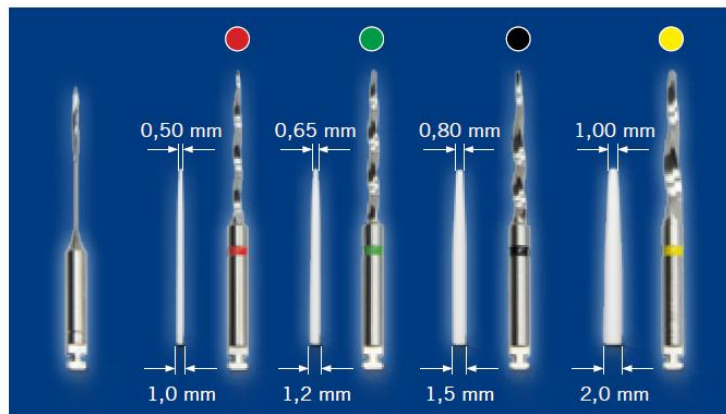
Preparación inicial.

- ☐ Confirmar tratamiento endodóntico completo y sellado.
- ☐ Radiografía periapical de control.
- ☐ Preparar aislamiento absoluto con dique de goma.

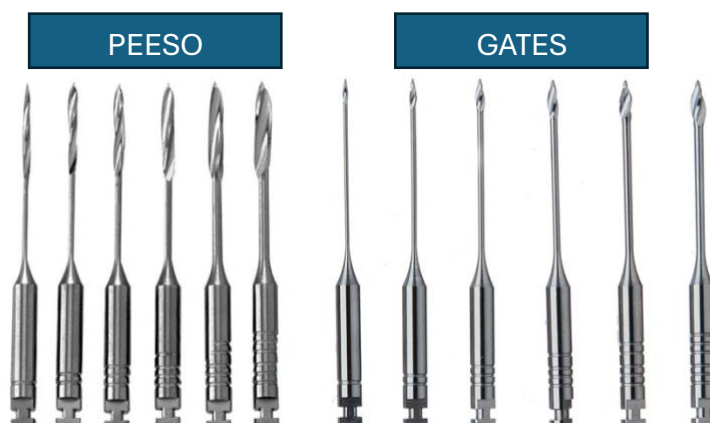
Instrumental y materiales.

- ☐ Postes de fibra de vidrio (Rebilda® Post).

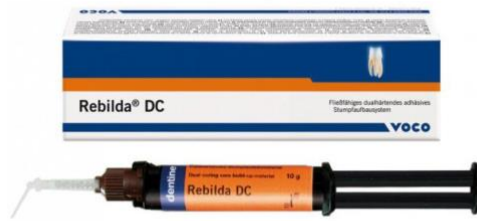
Tamaño	10 (rojo)	12 (verde)	15 (negro)	20 (amarillo)
Largo	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Diámetro coronal	1,00 mm	1,20 mm	1,50 mm	2,00 mm
Diámetro apical	0,50 mm	0,65 mm	0,80 mm	1,00 mm



- ☐ Contraángulo de baja velocidad.
- ☐ Fresas calibradas del sistema (Ø según poste) y fresas de desobturación (Gates-Glidden/Peeso-Reamer).



☐ Cemento de composite de curado dual.



☐ Adhesivo autograbable de curado dual.



☐ Silano.



☐ Ácido ortofosfórico al 37 % para grabado del esmalte remanente de la corona clínica

☐ Hipoclorito de sodio (2,5–5 %) para irrigación.

☐ Alcohol isopropílico.

☐ Puntas de papel ISO.

☐ Microbrushes.



- ☐ Cánulas de aplicación (QuickMix o similares).



- ☐ Lámpara de polimerización.
- ☐ Composite de reconstrucción.
- ☐ Fresas y discos de acabado/pulido.

Procedimiento clínico.

- ☐ Retirar gutapercha (manteniendo ≥ 4 mm de sellado apical).
- ☐ Preparar conducto con fresas calibradas a baja velocidad.
- ☐ Irrigar y limpiar durante el fresado con hipoclorito de sodio al 2,5–5 %.
- ☐ Aplicar ácido ortofosfórico al 37 % y aclarar con agua.
- ☐ Secar el conducto con puntas de papel.
- ☐ Limpiar poste con alcohol, silanizar y secar.
- ☐ Aplicar adhesivo autograbable de curado dual en el diente.
- ☐ Aplicar cemento dual en el conducto (QuickMix o cánula de mezcla).
- ☐ Insertar el poste con movimiento rotatorio suave.
- ☐ Eliminar excesos de cemento.
- ☐ Fotopolimerizar 40 sg.
- ☐ Reconstruir el muñón con composite en capas ≤ 2 mm.
- ☐ Ajustar anatomía y pulir superficie.
- ☐ Verificar oclusión.

ESQUEMA GRÁFICO “REBILDA POST SYSTEM”

